

Ортотопический неомочевой пузырь

Информация для пациента · Новый мочевой пузырь из кишечника, через который вы мочитесь естественным путём

WARWIKI

Ортотопический неомочевой пузырь — это новый мочевой пузырь, сформированный из собственного кишечника и соединённый с вашей уретрой. После удаления мочевого пузыря вы мочитесь привычным способом — без мешка. Потребуется время и практика, чтобы научиться хорошо опорожнять его и восстановить контроль.

Об этой операции

Примерно **40–60 см тонкой кишки** открывается и складывается в резервуар с низким давлением, который соединяется с **уретрой**; мочеточники (трубки от почек) отводят мочу в него. **Стомы и мешка нет.**

Поскольку новый пузырь сделан из кишечника, он **не** даёт привычного сигнала «хочу в туалет», поэтому вы учитесь:

- Мочиться **по расписанию** — расслабляя тазовое дно и слегка натуживаясь — включая **ночные пробуждения**.
- При необходимости применять катетер для полного опорожнения (чаще у женщин).
- Выполнять **упражнения для тазового дна** для улучшения контроля.

Контроль улучшается за **несколько месяцев**; в начале нередко бывает подтекание, особенно ночью. Операция подходит не всем — это зависит от состояния уретры, функции почек и готовности соблюдать режим.

Это безопасно?

Это хорошо изученная операция, дающая наиболее «естественный» результат. Она крупнее и длительнее, чем кондуит, и требует большего обучения. Риски: кровотечение, инфекция, несостоятельность швов, дневное и ночное подтекание, неполное опорожнение с необходимостью катетеризации, слизь, инфекции мочевыводящих путей (UTI), а также долгосрочные изменения электролитного и витаминного баланса, за которыми наблюдают при контрольных визитах.

ТЕРМИНЫ

Неомочевой пузырь

Новый мочевой пузырь, сформированный из фрагмента кишечника.

Ортотопический

Расположенный на обычном месте и соединённый с уретрой, что позволяет мочиться привычным способом.

Уретра

Трубка, по которой моча выходит из тела.

Мочеточники

Трубки, несущие мочу от почек в неомочевой пузырь.

Мочеиспускание по расписанию

Опорожнение по установленному графику (днём и ночью), а не по позыву.

Самокатетеризация

Самостоятельное введение тонкого катетера для полного опорожнения пузыря при необходимости.

Тазовое дно

Мышцы, которые тренируют для удержания и выделения мочи.

Слизь

Выделяемая кишечником жидкость; нити слизи в моче — норма.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Операция проводится под общей анестезией, поэтому вы ничего не чувствуете. После неё ожидайте болезненности в животе; кишечник «просыпается» несколько дней. В больнице обычно проводят 5–8 дней; сама операция длительная.

Как подготовиться (до операции)

- Операция под **общей анестезией** — соблюдайте все инструкции (голодание, отмена антикоагулянтов по назначению). Возможна **подготовка кишечника**.
- Осознайте необходимость: **мочеиспускание по расписанию днём и ночью**, возможная **самокатетеризация** и упражнения для тазового дна.
- Не курите** и организуйте помощь дома после выписки.

Заранее сообщите команде, если вы:

- Принимаете **антикоагулянты** или имеете активную инфекцию
- Страдаете **заболеванием кишечника**, болезнью почек, перенесли операции или облучение брюшной полости

Что происходит во время операции

- 1 Вы находитесь под анестезией; вводятся антибиотики.
- 2 Фрагмент кишечника выделяется, оставшиеся отделы соединяются.
- 3 Фрагмент вскрывается и складывается в резервуар, который пришивается к уретре.
- 4 Мочеточники вшиваются в резервуар; на время заживления устанавливаются катетер и мягкие стенты.

После операции

- Вы уходите домой через **5–8 дней с катетером на ~2–3 недели** (промывайте его от слизи); перед удалением выполняют **контрольный снимок** нового пузыря.
- Затем вы осваиваете **мочеиспускание по расписанию** (будильник ночью), упражнения для тазового дна и **самокатетеризацию** при неполном опорожнении.
- В начале ожидайте **подтекания** (особенно ночью) — оно уменьшается за месяцы. Слизь в моче нормальна; пейте достаточно жидкости; пожизненное наблюдение (витамин B12).

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры или озноб
- Вы **не можете помочиться** или катетер **перестал отводить мочу**
- Сильная боль в животе, рвота или **отсутствие газов и стула**
- Обильное кровотечение, покраснение или выделения из раны, боль в боку

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Неомочевой пузырь — новый резервуар из кишечника, соединённый с уретрой, что позволяет мочиться без мешка.
2. Нужна практика: мочеиспускание по расписанию днём и ночью, упражнения для тазового дна, иногда самокатетеризация. Контроль улучшается за месяцы, раннее подтекание нормально.
3. Соблюдайте инструкции по голоданию и подготовке кишечника, не курите. Не удаляйте катетер самостоятельно — его снимают после контрольного снимка.